

Información Paciente

Nombre : José Vicente Acevedo Bello
Edad : 73a 5m 9d
Dirección : Cleopatra 10577 B/32 Dpto/13

Rut : 5.283.507-0
Fecha Nacto: 23/01/1949
Comuna : La Florida

N° Archivo : 2201304
Sexo : Masculino
Teléfono : 998349020

N° Epicrisis
313633

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Hospitalización

Fecha Ingreso : 01/07/2022 19:30

Días Estadía : 1

Unidad de Egreso : Emergencia Adulto

Fecha Egreso : 02/07/2022 22:07

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Dolor torácico

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

1. A. médicos: Enfermedad coronaria de 3 vasos conocida, hipoacusia, LCFA.
Hospitalizado por IAM HASTA EL 13/06 CON bypass coronario con tres injertos de safena
2. Quirúrgicos: (-)
3. Fármacos:
 - Amiodarona 200mg 1 Comprimido Al Día Vía Oral
 - Atorvastatina 20mg 4 Comprimidos Cada Noche Vía Oral
 - Paracetamol 500mg 2 Comprimido Cada 8 Horas Vía Oral, X 15 Días
 - Atenolol 50mg 1/2 Comprimido Al Día Vía Oral
 - Acido Acetilsalicílico 100mg 1 Comprimido Al Día Cada 24 Horas
4. Alergias: (-)
5. Hábitos: TBQ (-) OH (-) Drogas (-)
6. Social: Vive con esposa

Consulta por dolor torácico en relación a herida operatoria, opresivo, asociado a movimientos.

ECG: sinusal, regular, FC 61, sin alteraciones del ST, T invertida asimétrica en pared lateral.

Exámenes:

- Hb 10.9 (previa 10.2), GB 9230, PCR 7.4, plaq 260.000,
- BUN 16, crea 0,92, Na 139, K 4.84, Cl 10
- TUS 62.9-60
- Rx : sin derrame, sin focos de condensación.

Diagnósticos de ingreso:

- Dolor torácico en estudio
- Antecedentes

Evolución:

- Hemodinamia: estable, sin DVA.
- Cardiológico: ECG seriado sin cambios, curva de troponina negativa. Sin arritmias durante estadía. Parámetros inflamatorios

Fecha Epicrisis : 02/07/2022 22:05

Fecha Última Actualización: 02-07-2022 22:05:59

Página 2 de 2

bajo. Evaluado por UCO impresiona dolor en relación a herida operatoria, mas que dolor de origen cardiogénico. Se realiza TAC de tórax que se informa con cambios postquirúrgicos, sin derrame pleural, neumotórax o derrame pericárdico. Se decide alta con optimización de analgesia y control con tratante.

Urgencia SOS.

Diagnóstico de Egreso

Dolor torácico -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente estable, sin mayor dolor, afebril, sin requerimientos de oxígeno.

Plan Post Alta

1. Reposo relativo. No realizar grandes esfuerzos.
2. Uso de faja.
3. Régimen liviano, bajo en sal
4. Medicamentos:
 - Paracetamol 500mg, 2 comprimidos cada 8 horas por 10 días
 - Metamizol 300mg cada 8 horas por 5 días.
 - Tramadol gotas, 5 gotas cada 12 horas en caso de dolor persistente. Ajustar dosis según dolor y efectos adversos (náuseas, vómitos, mareos). Explico a paciente y familiar que solo debe utilizar este medicamento en caso de dolor persistente.
 - Amiodarona 200mg, 1 Comprimido Al Día Vía Oral
 - Atorvastatina 20mg, 4 Comprimidos Cada Noche Vía Oral
 - Atenolol 50mg, 1/2 Comprimido Al Día Vía Oral
 - Acido Acetilsalicílico 100mg, 1 Comprimido Al Día Cada 24 Horas
4. Controles:
 - Control el miércoles 06/07 a las 13:00 horas con Dr. Fullerton en CDT cardiocirugía (sobrecupo autorizado por tratante).
 - Habituales con cardiología
5. Consultar antes en Servicio de Urgencia en caso de dolor intenso, gran dificultad respiratoria, desmayo, fiebre, o en caso de ser necesario.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

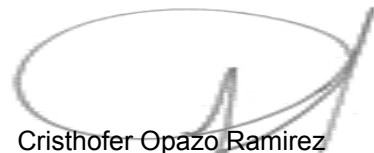
Régimen Alimentario : Hiposódico

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Cristhofer Opazo Ramirez

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 02/07/2022 22:05

Página 2 de 2

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:35

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar